

Sémiologie de l'appareil respiratoire : Douleurs thoraciques, vomique, dysphonie

Objectifs pédagogiques :

Connaitre les différents signes fonctionnels en pneumologie

I Douleurs thoraciques

Définition :

C'est une douleur qui siège au niveau du thorax, dont l'origine est multiple

Plusieurs organes sont responsables, elle peut être d'origine extra thoracique (les douleurs d'origine vésiculaire qui se projettent vers l'épaule), ou intra thoracique (poumon, plèvre, médiastin, cœur, œsophage, pariétal ...)

Au niveau du poumon, seule la plèvre et le parenchyme périphérique peuvent être responsable de douleur.

Description de la douleur :

La place de l'interrogatoire et de l'examen clinique est essentielle, dans la démarche diagnostique, il faut garder à l'esprit que certaines douleurs thoraciques peuvent révéler des urgences vitales.

➤ Localisation :

Les douleurs rétrosternales sont essentiellement d'origine cardiaque et médiastinale

Les douleurs latérothoraciques sont le plus souvent en rapport avec des affections pleurales ou pleuro-parenchymateuses, les douleurs de l'épaule sont soit le fait d'organes sous diaphragmatiques (foie ou vésicule à droite, rate à gauche) ou en rapport avec des affections des sommets pulmonaires.

➤ Irradiation :

Les douleurs pleurales irradient vers l'épaule ou l'hypochondre et le zona et les autres douleurs neurogènes irradient le long d'un trajet intercostal.

- **Etendue** : les douleurs pleurales, les douleurs pariétales et psychogènes sont habituellement très localisées
- **Type de douleur** : Les douleurs pleurales sont décrites comme « un coup de poignard ».
- **Intensité** : Les douleurs pleurales sont parfois intenses, L'inspiration majore les douleurs d'origine pleurale, La toux exacerbe les douleurs pleurales
- **Durée**
- **Circonstances déclenchantes**
- **Les signes associés**

Signes généraux (altération de l'état général dans un contexte néoplasique)

- respiratoires : dyspnée, toux, expectoration, hémoptysie
- infectieuses : fièvre, frissons
- vasculaires : douleur d'un membre inférieur
- digestives : vomissements, dysphagie, hématomèse
- neurologiques : syncope, lipothymie.

Au terme de cet interrogatoire on peut distinguer les douleurs ayant pour origine l'appareil respiratoire
sont des douleurs profondes caractérisées par :

- Elles sont exacerbées par la toux, l'inspiration profonde et le changement de position.
- Elle réalise une douleur unilatérale en point de côté.

1/ Douleur d'origine pleural :

A/ Epanchement pleural aérien ou pneumothorax : définit par la présence d'air entre les deux feuillets de la plèvre, c'est une douleur déchirante avec angoisse et dyspnée et éventuellement perte de connaissance, puis il y a une période d'adaptation en quelques minutes et la douleur devient supportable mais permanente.

B/ épanchement pleural liquidien : c'est la présence de liquide dans la cavité pleurale.

La douleur varie en fonction de la nature du liquide :

Liquide inflammatoire : elle contient du liquide séro-fibrineux, douleur d'intensité modérée à début progressif.

Pleurésie purulente : (empyème) si elle contient du pus, la douleur est de début brutal, d'intensité variable, signes accompagnateurs ; fièvre et altération de l'état général.

Hémothorax : si elle contient du sang, souvent post-traumatique, signes accompagnateurs : pâleur, signes de choc (hypotension, pouls filant)

2/ Douleur d'origine parenchymateuse :

➤ **Pneumonie franche lobaire aiguë :**

La douleur thoracique est sous-mamelonnaire à type de point de côté, fièvre, frissons, expectoration de coloration rouillée de Laennec, herpès.

➤ **Embolie pulmonaire :**

- Migration d'un embolie le plus souvent un caillot sanguin dans l'artère Pulmonaire ou l'une de ses branches
- La douleur est de début brutal, variable souvent vive, basithoracique, peut être parasternal avec irradiation en demi-ceinture dans les formes massives.

- Les signes accompagnateurs :

immédiat : dyspnée à type de polypnée, fièvre, tachycardie,

3/ Les douleurs d'origine pariétale :

- ✓ Douleur thoracique post-traumatique : s'accompagne cliniquement d'une ecchymose cutanée.
- ✓ Névralgie intercostale : douleur localisée qui s'accompagne souvent d'une douleur provoquée à la pression du thorax au point d'émergence d'un nerf intercostal.
- ✓ Névralgie phrénique : douleur thoracique basse, intense, irradiant le long du bord externe du sternum vers l'épaule et s'accompagnant d'un point douloureux provoqué sur le trajet du nerf phrénique.
- ✓ Zona : c'est une maladie infectieuse due à un virus à tropisme neuro-ectodermique qui se manifeste par une éruption érythémato-vésiculeuse de trajet radiculaire et par une douleur thoracique à type de causalgie : sensation de cuisson ou parfois à type de névralgie.
- ✓ Syndrome de Tietze : douleur localisée au niveau d'une articulation chondro-sternale ou chondro-costale s'accompagnant d'une tuméfaction de cette articulation.

La vomique

Définition :

La vomique est une variété d'expectoration caractérisée par son apparition brutale et le plus souvent massive :

C'est le rejet brusque par la bouche d'une grande quantité de pus ou de liquide clair dans un effort de toux ayant pénétré suite à l'effraction dans les bronches

caractéristiques sémiologiques de la vomique

1. Suivant la qualité du liquide rejeté

La vomique purulente :

C'est le rejet de pus provenant du poumon (abcès du poumon), de la plèvre (pleurésie purulente) ou de la région sous-phrénique (abcès sous-phrénique).

La vomique eau de roche :

C'est le rejet d'un liquide clair, eau de roche, de saveur salée, et contenant des débris de membranes blanchâtres il peut s'accompagner d'un choc anaphylactique.

Elle se voit lors de rupture d'un kyste hydatique intra parenchymateux dans les Bronches

2. Suivant la quantité de liquide rejeté :

La vomique massive :

- elle revêt une allure dramatique, lors d'un effort ou d'une quinte de toux
- le malade ressent une douleur thoracique déchirante et rejette un flot de pus par la bouche, au milieu de quintes de toux, parfois d'efforts de vomissement.

La vomique fractionnée :

- rejet de liquide le plus souvent de pus par petites quantités mais de manière répétée.

La vomique nummulaire ou masquée :

- réduite à de simples crachats purulents plus ou moins nombreux, rapprochés.
- Ces deux derniers types sont moins caractéristiques que la vomique massive ;
_une vomique se caractérise essentiellement par :

Le mode de début toujours subit.

En cas de vomique purulente il s'agit de pus franc.

La quantité rejetée dans les 24 heures est en général abondante.

La dysphonie

Définition :

La dysphonie est une altération de la voix (enrouement).

Il peut s'agir d'extinction plus ou moins complète ou de voix bitonale (avec production alternée de sons graves et aigus).

Il existe différentes variétés de troubles de la voix ou dysphonie :

1. La voix peut être rauque ou éteinte :

ceci se voit au cours de la laryngite diphtérique ou croup.

2. La voix nasonnée :

Présente en cas d'encombrement du cavum et en cas de paralysie du voile du palais.

3. La voix bitonale :

est une voix alternativement élevée et grave, appelée aussi « voix de fausset ».

Elle traduit le plus souvent la paralysie d'une corde vocale.